โครงการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล (CQI)

Hip B(Lock) Ultra Smooth

หมอนกางขาป้องกันข้อสะโพกเทียมเคลื่อนหลุด หลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม

หลักสูตรเฉพาะทางการพยาบาลปริศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ ประจำปีการศึกษา 2569
หน่วยผ่าตัดออร์โธปิดิคส์ โรงพยาบาลศิริราช

02 · ผู้รับผิดชอบโครงการ

คณะผู้จัดทำ

ชื่อ–สกุล	รหัสนักศึกษา
นางสาวกนกวรรณ บวรพิพัฒนชัย	6911801
นายกิตติวัฒน์ ผัดอาจ	6911803
นางสาวสินีพิชญ์ ทองฉิม	6911833
นางสาวสุธาพร สำราญมาก	6911836
นายอดิศักดิ์ ศักดิ์มาก	6911842
นางสาวอรพิน รุ่งเรือง	6911844

ที่ปรึกษาโครงการ

พว.อัญชลี ศรีสุข

หลักสูตรเฉพาะทางการพยาบาลปริศัลยกรรม ประจำปีการศึกษา 2569





ภาพตัวอย่าง

03 · ที่มาของโครงการ

ข้อสะโพกเทียมเคลื่อนหลุด คือภาวะแทรกซ้อนสำคัญ

2–4%

อุบัติการณ์ข้อสะโพกเทียมเคลื่อนหลุดหลังผ่าตัด

Korfitsen et al., 2023

223 · 176 · 188

รายที่ผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม ปี 2566 · 2567 · 2568

หน่วยผ่าตัดออร์โธปิดิคส์ ศิริราช, 2569

ทุกราย

ผ่าตัดแบบ posterior approach เสี่ยงข้อหลุดสูงกว่าวิธีอื่น

Dimentberg et al., 2023

- การผ่าตัด THA และ Bipolar hemiarthroplasty ช่วยลดปวด เพิ่มการเคลื่อนไหว และคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย
- เมื่อข้อหลุด ผู้ป่วยปวด ต้องดึงข้อกลับเข้าที่ บางรายต้องผ่าตัดซ้ำ นอนโรงพยาบาลนานขึ้น และค่ารักษาเพิ่มขึ้น

แนวทางป้องกันข้อสะโพกเคลื่อนหลุดใน 48 ชั่วโมงแรกหลังผ่าตัด

ควรทำ

- นอนหงายราบ กางขา 15–30 องศา
- วางหมอนระหว่างขา ให้ขาตั้งตรง
- พลิกตะแคงแบบพลิกทั้งตัว (log roll) ไปด้านที่ไม่ผ่าตัด
- ขาข้างผ่าตัดเหยียดตรง สอดหมอนไว้ระหว่างขา

ต้องหลีกเลี่ยง

- งอสะโพก (flexion) เกิน 90 องศา
- หุบขาข้ามแนวกึ่งกลางลำตัว (adduction)
- หมุนสะโพกเข้าใน (internal rotation)
- หมุนสะโพกออกด้านนอก (external rotation)

ที่มา: วรภักดิ์สกุล สุขดี, 2565

03 · ที่มาของโครงการ

ทำไมต้องมีหมอนกางขา

ปัญหา

- ผู้ป่วยสับสน สมองเสื่อม หรือไม่ให้ความร่วมมือ
- ขณะพักหรือนอนหลับ อาจพลิกตัวหรือขยับขาโดยไม่รู้ตัว
- ข้อสะโพกอยู่ในท่าที่ไม่เหมาะสม เสี่ยงต่อการเคลื่อนหลุด

แนวคิดนวัตกรรม

- ประคองขาทั้งสองข้างให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม
- ลดการหุบขาเข้าหากันหรือไขว้ขา
- เพิ่มความมั่นคงของข้อสะโพกขณะนอนพัก
- บุคลากรจัดท่าได้สะดวก ผู้ป่วยและญาติมั่นใจขึ้น
- ยกขาสูง ส่งเสริมการไหลเวียนของเลือด ลดบวม และช่วยเรื่องความสุขสบายหลังผ่าตัด

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาหมอนกางขา ที่สามารถช่วยรองขา ล็อกขา และผิวสัมผัสนุ่มสำหรับผู้ป่วยหลังได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม
2. เพื่อป้องกันอุบัติการณ์ข้อสะโพกเทียมเคลื่อนหลุดขณะเคลื่อนย้ายหรือพลิกตะแคงตัวผู้ป่วยหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรต่อการใช้งานHip B(Lock) Ultra Smoothในการดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม

แนวคิด/ทฤษฎีที่นำมาประยุกต์ใช้

1

ทฤษฎีการจัดท่าเพื่อป้องกันข้อสะโพกเทียมเคลื่อนหลุด

Hip Positioning and Dislocation Prevention

2

ทฤษฎีการยกอวัยวะส่วนปลายสูงเพื่อลดอาการบวม

Elevation Therapy

3

ทฤษฎีความมั่นคงและการรองรับอวัยวะ

Stability and Support Theory

4

ทฤษฎีแรงเสียดทานและแรงเฉือน

Friction and Shear Force

1 · Hip Positioning and Dislocation Prevention

ทฤษฎีการจัดท่าเพื่อป้องกันข้อสะโพกเทียมเคลื่อนหลุด

หลักการ

ข้อสะโพกเป็นข้อต่อแบบ ball and socket หลังผ่าตัด THA ด้วย posterior approach เนื้อเยื่อรอบข้อยังอยู่ในระยะฟื้นตัว จึงเสี่ยงต่อข้อเคลื่อนหลุด

ท่าที่ต้องหลีกเลี่ยง

- งอสะโพกเกิน 90 องศา
- หุบขาข้ามแนวกึ่งกลางลำตัว
- หมุนสะโพกเข้าด้านใน

งานวิจัยสนับสนุน

- Chan และคณะ (2025) scoping review: มีหลักฐานสนับสนุนการใช้อุปกรณ์ประคองขาช่วงเคลื่อนย้ายจากเตียงผ่าตัดไปเตียงผู้ป่วย
- Eslam Pour และคณะ (2023): กางสะโพกประมาณ 20 องศา ลดการชนกันของกระดูกกับข้อเทียม (impingement) ในแบบจำลองคอมพิวเตอร์

การประยุกต์ใช้กับนวัตกรรม

รองรับขาทั้งสองข้าง ประคองแนวขาและสะโพก ลดการหุบขา ปรับตำแหน่งตามข้อจำกัดของผู้ป่วยแต่ละราย

2 · Elevation Therapy

ทฤษฎีการยกอวัยวะส่วนปลายสูงเพื่อลดอาการบวม

หลักการ

ภายหลังผ่าตัดอาจบวมจากการตอบสนองต่อการอักเสบ หลอดเลือดฝอยซึมผ่านมากขึ้น และสารน้ำคั่งในช่องว่างระหว่างเซลล์ การยกขาสูงอย่างเหมาะสมช่วย

- ลดแรงดัน Hydrostatic pressure ในหลอดเลือดดำส่วนปลาย
- ส่งเสริมการไหลกลับของเลือดดำ
- ช่วยระบายของเหลวผ่านระบบน้ำเหลือง
- ลดการคั่งของสารน้ำบริเวณปลายขา

การประยุกต์ใช้กับนวัตกรรม

Hip B(lock) Ultra Smooth ออกแบบให้สามารถรองรับขา ล็อกขาให้อยู่กับที่และสามารถยกปลายเท้าสูงได้ เพื่อไม่ทำให้ข้อสะโพกเสี่ยงต่อการเลื่อนหลุด และเพิ่มการไหลเวียนเลือดดำกลับสู่หัวใจ

3 · Stability and Support Theory

ทฤษฎีความมั่นคงและการรองรับอวัยวะ

หลักการ

ข้อสะโพกต้องมั่นคง โดยเฉพาะขณะ

- เปลี่ยนท่า พลิกตะแคง
- เคลื่อนย้ายจากเตียงไปรถเข็นหรือเปล

การเคลื่อนไหวที่ไม่สัมพันธ์กันของลำตัวและขา ทำให้เกิดแรงบิดต่อข้อสะโพก ข้อจึงไม่มั่นคงและมีโอกาสเลื่อนหลุด

งานวิจัยสนับสนุน

Chan และคณะ (2025) เป็น scoping review เกี่ยวกับข้อควรระวังหลังผ่าตัด THA มีการสนับสนุนการใช้อุปกรณ์ประคองขาในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากเตียงผ่าตัด เป็นช่วงที่ควรให้ความสำคัญแนวขาเป็นพิเศษ

การประยุกต์ใช้กับนวัตกรรม

ออกแบบ Hip B(lock) Ultra Smooth ให้มีฐานรองรับมั่นคง มีพื้นที่รองรับขาเหมาะสม และสามารถช่วยประคองขาไม่ให้เคลื่อนออกจากตำแหน่งขณะเคลื่อนย้ายผู้ป่วย จะช่วยเพิ่มความความปลอดภัยและลดการเคลื่อนไหวไม่พึงประสงค์

4 · Friction and Shear Force

ทฤษฎีแรงเสียดทานและแรงเฉือน

หลักการ

การเสียดสีระหว่างผิวหนังกับพื้นผิวรองรับขณะเคลื่อนย้าย ทำให้เกิด

- **แรงเสียดทาน (friction)** แรงที่ต้านการเคลื่อนที่ระหว่างพื้นผิว 2 ชนิด
- **แรงเฉือน (shear force)** แรงที่ทำให้เนื้อเยื่อเคลื่อนตัวในทิศทางขนานกับพื้นผิว

ส่งผลให้เกิดผิวหนังระคายเคือง ความไม่สุขสบาย และเพิ่มความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บเนื้อเยื่อ

งานวิจัยสนับสนุน

Schwartz และคณะ (2018): พบว่า ความชื้นทำให้ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานเพิ่มขึ้น อาจเพิ่มแรงเฉือนต่อผิวหนังและเนื้อเยื่อชั้นลึก

การประยุกต์ใช้กับนวัตกรรม

หุ้มด้วยผ้าซาตินผิวเรียบลื่น ลดแรงต้านขณะเคลื่อนย้าย ขาและจัดท่า ลดการเสียดสีบริเวณผิวหนัง

06 · ทรัพยากรที่ใช้

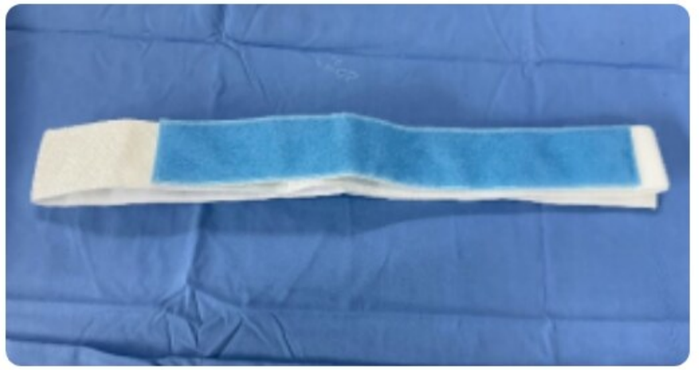
วัสดุ 6 อย่าง หาได้ง่ายในหน่วยงาน



ฟองน้ำความหนาแน่นสูง



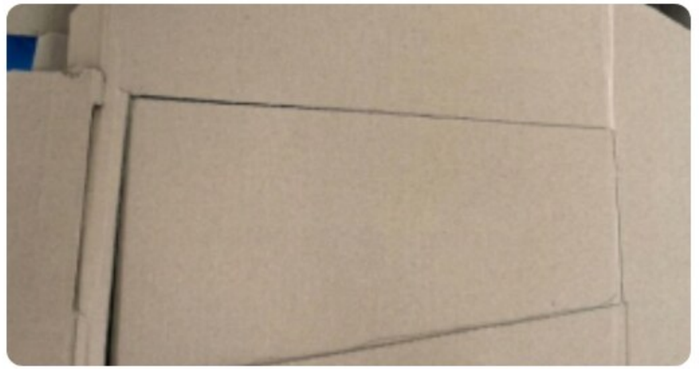
ผ้าซาติน



เทปหนามเตย



ซิป



กระดาษลัง



ฟิล์มยืดถนอมอาหาร

06 · ทรัพยากรที่ใช้

วัสดุหลัก 2 อย่าง และเหตุผลที่เลือก



6.1 ฟองน้ำความหนาแน่นสูง (high-density foam)

- **รองรับน้ำหนักและแรงกดทับได้ดี** รักษาความสูงและมุมของขาให้คงที่
- **คงรูปและคืนตัวได้เร็ว** ไม่ยุบตัวง่ายแม้รับน้ำหนักมาก
- **ทนทานสูง** อายุการใช้งานยาวนาน



6.2 ผ้าซาติน

- **ผิวเรียบเนียน นุ่ม มีความลื่นสูง** ลดแรงเสียดทาน (friction) และแรงเฉือน (shear)
- **ระบายอากาศได้ดี** ไม่ยับ ซักง่าย ไม่ดูดซับสิ่งสกปรก

06 · ทรัพยากรที่ใช้

ทำไมถึงใช้สีเขียว ?



ทางจิตวิทยา

ให้ความรู้สึกสงบ สดชื่น มีชีวิตชีวา

ทางศาสตร์จีน

ช่วยฟื้นฟูพลังงานในร่างกาย บรรเทาความเครียด และสร้างความรู้สึกร่มเย็นเป็นสุข

ทางการแพทย์

ช่วยปรับสมดุลสายตา ทำให้ดวงตาผ่อนคลาย ลดความพร่ามัวและเมื่อยล้าของดวงตา

06 · งบประมาณที่ใช้

ต้นทุนรวมเพียง 613 บาท

รายการ	ราคา
1. ฟองน้ำความหนาแน่นสูง (high-density foam)	400 บาท
2. ผ้าซาติน เมตรละ 40 บาท × 3 เมตร	120 บาท
3. เทปหนามเตย (จาก Star sleeve)	ฟรี
4. ซิป	66 บาท
5. กระดาษลัง (จากกล่องพัสดุในหน่วยงาน)	ฟรี
6. ฟิล์มยืดถนอมอาหาร	27 บาท
รวม	613 บาท

613

บาท ต่อชุด

ได้วัสดุฟรี 2 รายการ

ขั้นตอนการดำเนินงาน

1

ขั้นตอนที่ 1

วางแผน

จัดประชุมกลุ่มและวางแผนการดำเนินโครงการ

2

ขั้นตอนที่ 2

ทบทวนปัญหา

ทบทวนอุบัติการณ์ข้อสะโพกเทียมเคลื่อนหลุด (dislocation) หลังผ่าตัดในช่วง 3 ปี (2566–2568)

3

ขั้นตอนที่ 3

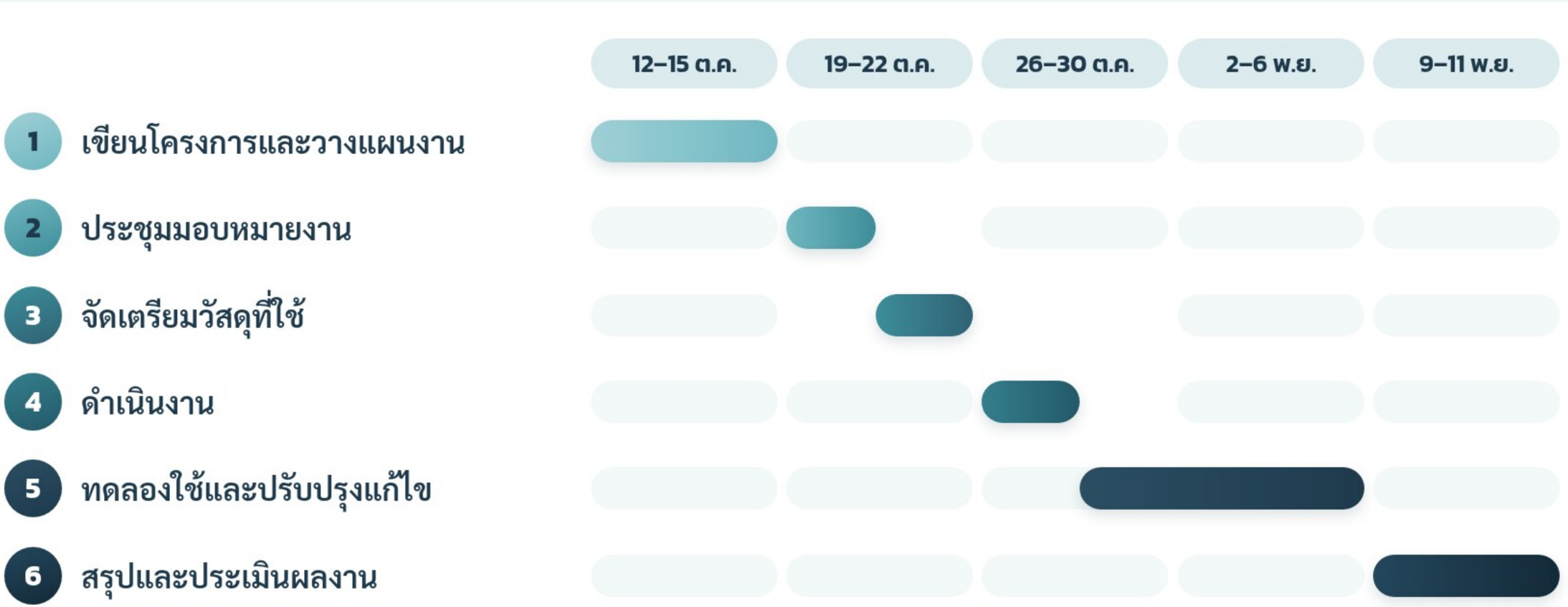
ออกแบบนวัตกรรม

ออกแบบ Hip B(Lock) Ultra Smooth และพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยวงจร PDCA 3 รอบ

07 · ระยะเวลาการดำเนินการ

12 ตุลาคม – 11 พฤศจิกายน 2569

ทดลองใช้ในหน่วยผ่าตัดออร์โธปิดิคส์ โรงพยาบาลศิริราช



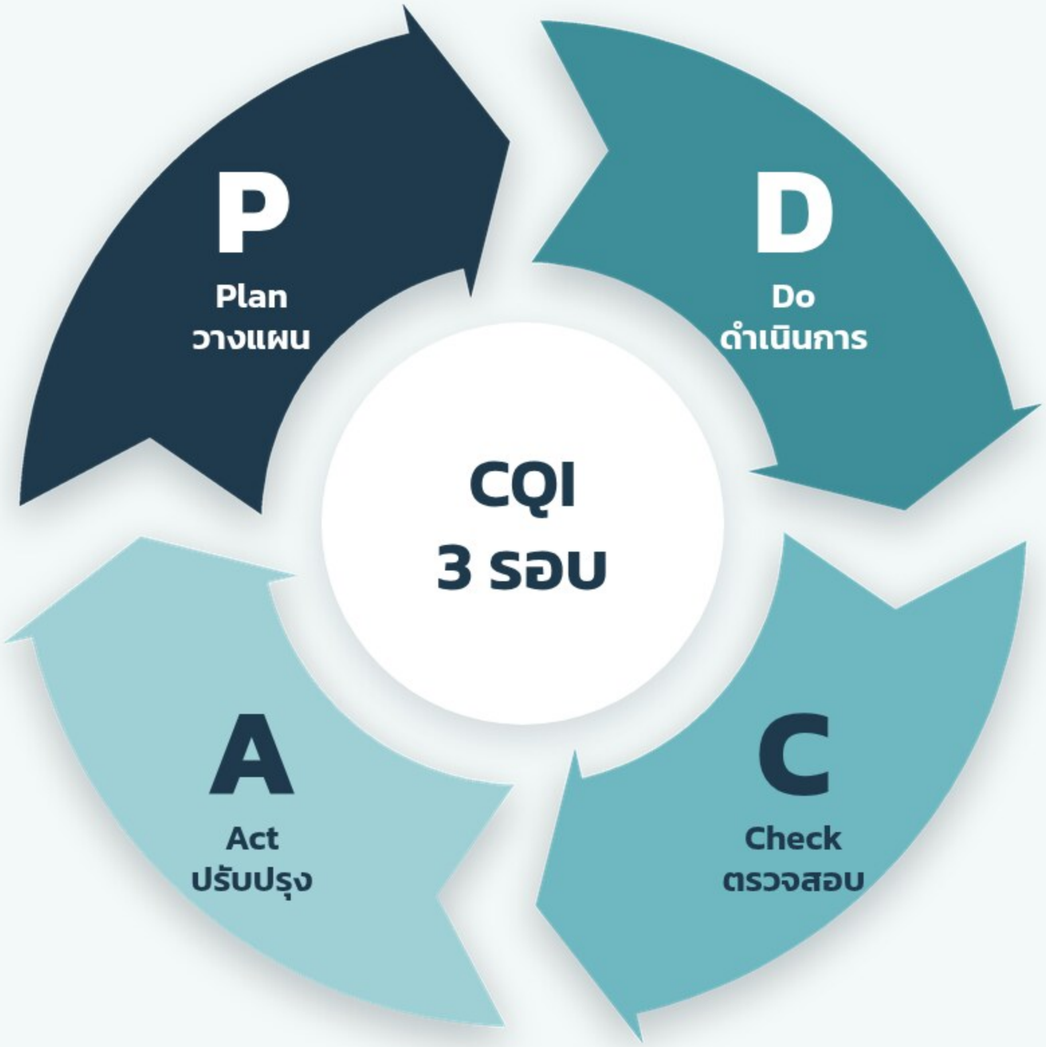
07 · ขั้นตอนการดำเนินงาน

ประเด็นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในแต่ละรอบของ CQI โดยใช้หลัก PDCA

รอบที่ 1 ค้นหาปัญหาและพัฒนาต้นแบบ

รอบที่ 2 ทดลองใช้และปรับปรุงประสิทธิภาพ

รอบที่ 3 พัฒนาอย่างต่อเนื่อง



07 · PDCA รอบที่ 1

ค้นหาปัญหาและพัฒนาต้นแบบ

P
Plan
วางแผน

- รวบรวมข้อมูลสถิติและทบทวนอุบัติการณ์ความเสี่ยงจากการจัดท่าผู้ป่วยที่ต้องกางขาหลังผ่าตัด
- ออกแบบหมอนกางขาให้มีฐานกว้างและองศาพอดี เพื่อเป็นแกนกลาง (Blocker)
- ออกแบบบล็อกล็อกขาข้างที่ผ่าตัดสูง 45 องศา เพื่อเพิ่มการไหลเวียนกลับหลอดเลือดดำ

D
Do
ดำเนินการ

- สร้างต้นแบบ (prototype) หมอนสามเหลี่ยมกางขา โดยใช้ฟองน้ำลักษณะนุ่ม
- กำหนดสเปกหมอนกางขา ให้มีฐานกว้าง และทำมุมองศาพอดีกับการพยุงขา

C
Check
ตรวจสอบ

- ประเมินประสิทธิภาพเบื้องต้น พบว่าการต้านทานน้ำหนักขา มีการยุบตัวของวัสดุที่อาจทำให้ขาหุบเข้าหากัน (adduction drift)



A
Act
ปรับปรุง

- วัสดุเดิมรับน้ำหนักไม่พอ เปลี่ยนเป็นฟองน้ำความหนาแน่นสูง (high-density foam) ไม่ยุบตัว คืนตัวดี กระจายแรงกดทับได้ดี

07 · PDCA รอบที่ 2

ทดลองใช้จริงและปรับปรุงประสิทธิภาพ

P

Plan
วางแผน

- นำข้อเสนอแนะจากรอบที่ 1 มากำหนดแนวทาง ทดลองใช้หมอนกางขา ที่สามารถล็อกขา และสามารถช่วยยกขาสูง มาทดลองใช้จริง





D

Do
ดำเนินการ

- ทดลองใช้ต้นแบบที่ปรับปรุงแล้วในห้องผ่าตัด
- หุ้มด้วยผ้าซาติน ลดแรงเสียดทานบริเวณข้อพับขา
- ทดลองใช้ขณะเคลื่อนย้ายผู้ป่วย และนำไปตรวจสอบถ่ายภาพรังสี
- ชี้แจงทีม สาธิตการวางหมอนกางขาที่สามารถล็อกขาและยกขาสูงได้ 45 องศา เพื่อล็อกองศาการกางขาให้ถูกต้อง

C

Check
ตรวจสอบ

- ข้อสะโพกเคลื่อนหลุด/ขาหุบผิดรูป ขณะเคลื่อนย้าย ต้องเป็น 0 ครั้ง
- การเกิดแผลกดทับระดับ 1 ขึ้นไป ต้องเป็น 0 ครั้ง
- x-ray หลังผ่าตัดได้โดยไม่ใช้อุปกรณ์จัดท่าพิเศษ
- สามารถใช้ได้ทั้งสองข้างหรือไม่

A

Act
ปรับปรุง

- ปรับรูปแบบบล็อคล็อคขาข้างที่ผ่าตัด ให้ใส่ได้ทั้งขาซ้ายและขวา ให้เหมาะกับสะโพกข้างที่ผ่าตัด

07 · PDCA รอบที่ 3

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

P
Plan
วางแผน

- ทบทวนข้อมูลและปัญหาที่อาจเกิดขึ้นหลังการใช้งานจริงในระยะยาว ตั้งแต่ออกจากห้องผ่าตัด จนถึงห้องพักฟื้น

D
Do
ดำเนินการ

- ปรับปรุงอุปกรณ์หรือกระบวนการดูแลตามข้อมูลจากการทบทวนอย่างเป็นระบบ
- สามารถใช้อุปกรณ์ได้ทั้งขาซ้ายและขาขวา

C
Check
ตรวจสอบ

- รวบรวมประเมินความพึงพอใจและการใช้งาน (usability & ergonomics): ความสะดวกในการจัดท่า ความมั่นคงของอุปกรณ์ ขณะเคลื่อนย้ายไม่เกิดข้อสะโพกเคลื่อนหลุด

A
Act
ปรับปรุง

- ทำสื่อให้ความรู้ (โปสเตอร์/สื่อนำเสนอ) เป็นแนวทางมาตรฐาน
- ขยายผลการใช้หมอนจากห้องพักฟื้นไปยังหอผู้ป่วย

ตัวต้นแบบ : หมอนฟองน้ำ



วิธีทำ

นำฟองน้ำลักษณะนุ่มมาออกแบบ

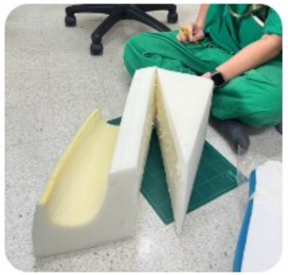
- ▲ รูปสามเหลี่ยม เพื่อให้กางขา
- ∪ รูปตัว U รองรับขา

ปัญหาที่พบ

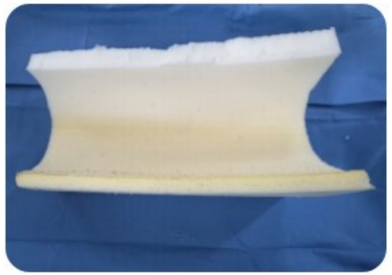
- ! ฟองน้ำนุ่ม ทำให้ยุบตัวเมื่อใช้งาน
- ! ไม่สามารถประคองขาได้
- ! ไม่สามารถใช้ได้ทั้งสองข้าง

07 · ขั้นตอนการประดิษฐ์ · รอบที่ 2

พัฒนาและปรับปรุง : หมอน 2 ชิ้น พร้อมปลอกหุ้มและสายรัดขา



1 ตัดฟองน้ำความหนาแน่นสูงเป็น**หมอนกางขา**ทรงสี่เหลี่ยมคางหมู ให้ขากางได้ 30 องศา



2 ตัด**บล็อคล็อคขา**รูปตัว U ร่องเว้าตามรูปขา เอียงขึ้น 45 องศา ทางปลายเท้าให้ส้นเท้าลอย



3 ทดลองจัดท่า ตรวจสอบให้ขาอยู่ในบล็อค ขาสามารถกางได้ ส้นเท้าลอย แล้วปรับขนาดให้พอดี



4 หุ้มฟองน้ำความหนาแน่นสูงด้วยแผ่นฟิล์มเพื่อกันน้ำและให้ใช้งานได้นานขึ้น



5 เย็บปลอกผ้าหุ้มหมอนทั้งสองชิ้น ด้วยผ้าซาติน มีซิปด้านบน ถอดซักและเช็ดทำความสะอาดได้



6 เย็บเทปหนามเตยยึดสองชิ้นเข้าด้วยกัน สลับใช้ได้ทั้งขาซ้ายและขวา เย็บสายรัดที่หมอนกางขา

07 · ผลงาน

ผลงาน Hip B(lock) Ultra Smooth



หมอน 2 ชิ้น พร้อมสายรัดขา



มุมข้าง : ส้นเท้าลอยพ้นเตียง



มุมบน : จัดท่าจริงบนเตียง

07 · ขั้นตอนการใช้งาน

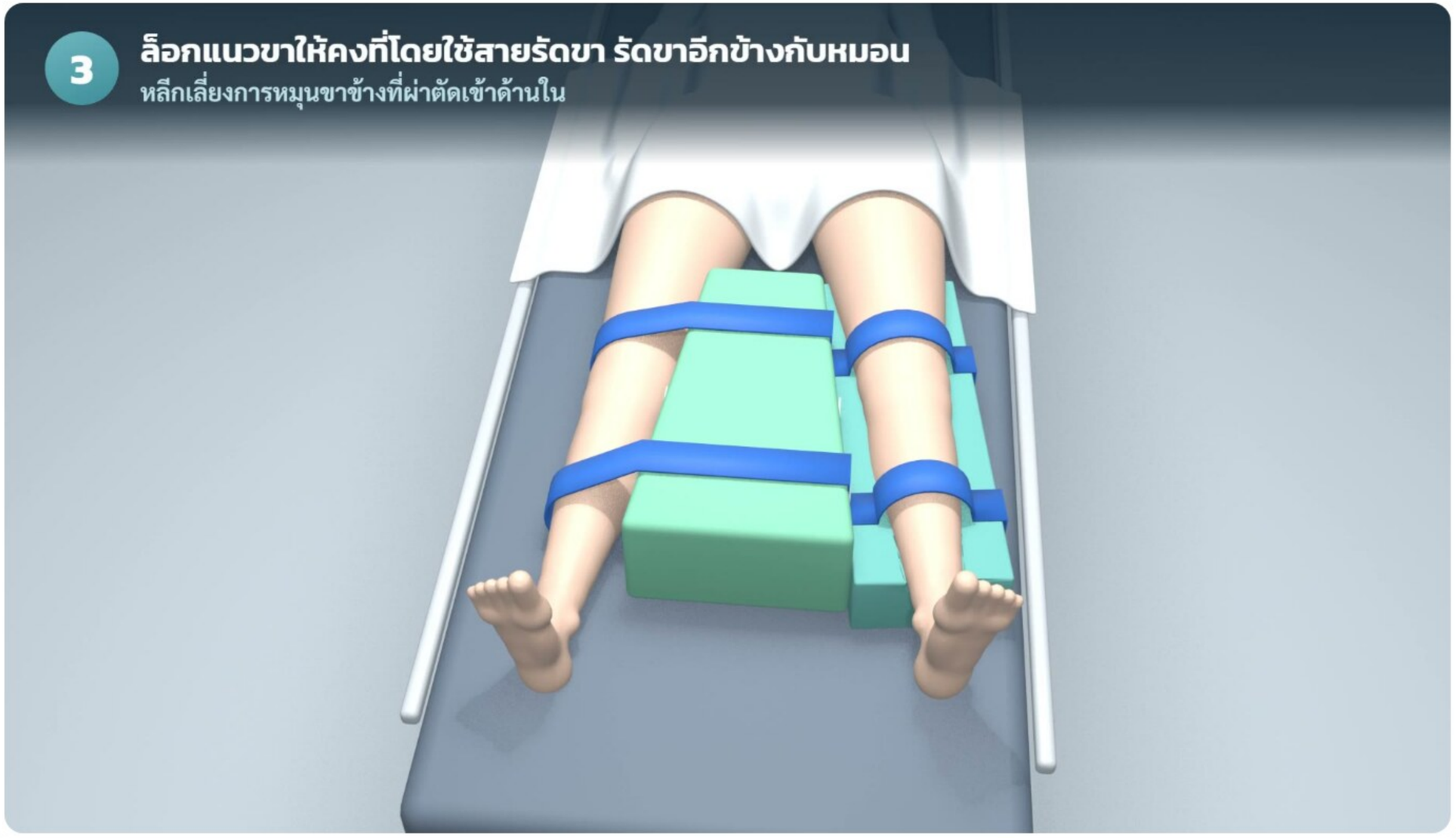
ขั้นตอนการใช้งาน

1. จัดผู้ป่วยนอนหงายราบ วางหมอนระหว่างขา ด้านแคบ อยู่ฝั่งต้นขาด้านกว้าง อยู่ฝั่งปลายเท้า ให้ขาข้างที่ผ่าตัดกาง 30 องศา
2. ประกบบล็อคล็อคขาติดกับหมอนกางขา วางขาข้างผ่าตัดบนบล็อคล็อคขา หนุนตั้งแต่ใต้ข้อพับเข่าจนถึงน่อง หัวเข่าและปลายเท้าตั้งตรง
3. ล็อกแนวขาให้คงที่โดยใช้สายรัดขา รัดขาอีกข้างกับหมอน หลีกเลี่ยงการหมุนขาข้างที่ผ่าตัดเข้าด้านใน
4. ตรวจสอบหลังการจัดท่า
5. เมื่อใช้เสร็จ ปลดสายรัด ตรวจสอบผิวหนัง ถอดปลอกหุ้ม เช็ดทำความสะอาดก่อนใช้กับผู้ป่วยรายต่อไป

ตรวจทุกครั้ง

- ขาข้างที่ผ่าตัดกางออก 30 องศา
- ข้อพับใต้เข่าไม่ถูกกดและส้นเท้าลอย
- สายรัดไม่กดหรือแน่นเกินไป
- เข่าและปลายเท้าตั้งตรงขึ้นด้านบน

ขั้นตอนการใช้งาน



07 · ผลการใช้งาน

ผลการทดลอง Hip Block Ultra Smooth



1 ห้องเอกซเรย์



2 ทดลองใช้งานจริง



3 ฟิล์มเอกซเรย์

08 · ตัวชี้วัดผลสำเร็จ

ตัวชี้วัดผลสำเร็จของโครงการและผลลัพธ์

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลลัพธ์
1. อุบัติการณ์เกิดแผลกดทับระดับ 1 ขึ้นไปหลังใช้งานนวัตกรรม	0 ครั้ง	✓ ผ่าน 0 ครั้ง
2. อุบัติการณ์เกิดข้อสะโพกหลุดขณะเคลื่อนย้าย/พลิกตะแคง	0 ครั้ง	✓ ผ่าน 0 ครั้ง
3. อัตราการถ่ายภาพรังสีหลังผ่าตัดได้โดยไม่ใช้อุปกรณ์จัดท่าพิเศษ	100%	✓ ผ่าน 100%
4. ความพึงพอใจของบุคลากร	≥ ร้อยละ 85	✓ ผ่าน ร้อยละ 87.1

✓ ผ่านเกณฑ์ครบทั้ง 4 ตัวชี้วัด

ผู้ป่วยหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมที่ใช้ Hip B(Lock) Ultra Smooth

ความพึงพอใจต่อการใช้งาน

ความพึงพอใจโดยรวม

87.1%

ระดับมากที่สุด

(เกณฑ์ ≥ 85%)

ผู้ตอบแบบประเมิน

พยาบาล	50%
ผู้ช่วยพยาบาล	30%
นักรังสีทางการแพทย์	20%

รายการประเมิน	ค่าเฉลี่ย	ร้อยละ	แปลผล
1. ด้านการออกแบบและวัสดุ			
1.1 ขนาดและรูปทรงเหมาะสมกับสรีระผู้ป่วย	4.3	86	มากที่สุด
1.2 วัสดุแข็งแรง คงรูป ไม่ยุบตัวขณะรองรับน้ำหนักขา	4.0	80	มาก
1.3 ปลอกผ้าซาตินนุ่มลื่น ไม่ระคายเคืองผิวผู้ป่วย	4.5	90	มากที่สุด
2. ด้านประสิทธิภาพในการดูแลและความปลอดภัยของผู้ป่วย			
2.1 ประคองขาและล็อกองศาการกางขาได้มั่นคง ลดความเสี่ยงข้อสะโพกหลุด	4.3	86	มากที่สุด
2.2 บล็อคล็อคขายกปลายเท้าสูง ส้นเท้าลอยพ้นเตียง ลดความเสี่ยงแผลกดทับ	4.4	88	มากที่สุด
2.3 สายรัดตีนตุ๊กแกกระชับ มั่นคงขณะเคลื่อนย้าย ไม่รัดแน่นจนกดทับผิวหนัง	4.3	86	มากที่สุด
3. ด้านความสะดวกในการปฏิบัติงานของบุคลากร			
3.1 สลับใช้งานได้ทั้งขาซ้ายและขวาอย่างคล่องตัว	4.6	92	มากที่สุด
3.2 ถ่ายภาพรังสี x-ray หลังผ่าตัดได้ทันทีโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์จัดท่าเพิ่ม	4.4	88	มากที่สุด
3.3 จัดท่าผู้ป่วยได้ง่าย สะดวก และประหยัดเวลาในการปฏิบัติงาน	4.4	88	มากที่สุด

09 · แผนพัฒนาต่อ

การพัฒนาปรับปรุง

1

ขยายผลการใช้งาน

ใช้หมอนต่อเนื่องจากห้องผ่าตัด ไปยังห้องพักฟื้น และหอผู้ป่วย

ห้องผ่าตัด > ห้องพักฟื้น > หอผู้ป่วย

2

QR Code และสายรัดขา

- ติด QR Code ขั้นตอนการใช้งานไว้ที่หมอน Hip Block เพื่อความสะดวกในการใช้งาน

สแกน QR Code > ดูขั้นตอน > วางหมอนถูกด้าน

- ปรับสายรัดขาเป็นแบบสายเข็มขัด เพื่อเพิ่มความแข็งแรงและกระชับ

สรุปผลการดำเนินการ

1. ความปลอดภัยของผิวหนัง

ไม่เกิดอุบัติการณ์แผลกดทับระดับ 1 ขึ้นไป หมอนยกส้นเท้าให้ลอย หุ้มผ้าซาตินลดแรงเสียดทานและแรงเฉือน

2. ป้องกันข้อสะโพกเทียมหลุด

ไม่เกิดอุบัติการณ์ข้อสะโพกเทียมเคลื่อนหลุดขณะเคลื่อนย้ายหรือพลิกตะแคง หมอนล็อกองศาการกางขาได้มั่นคง

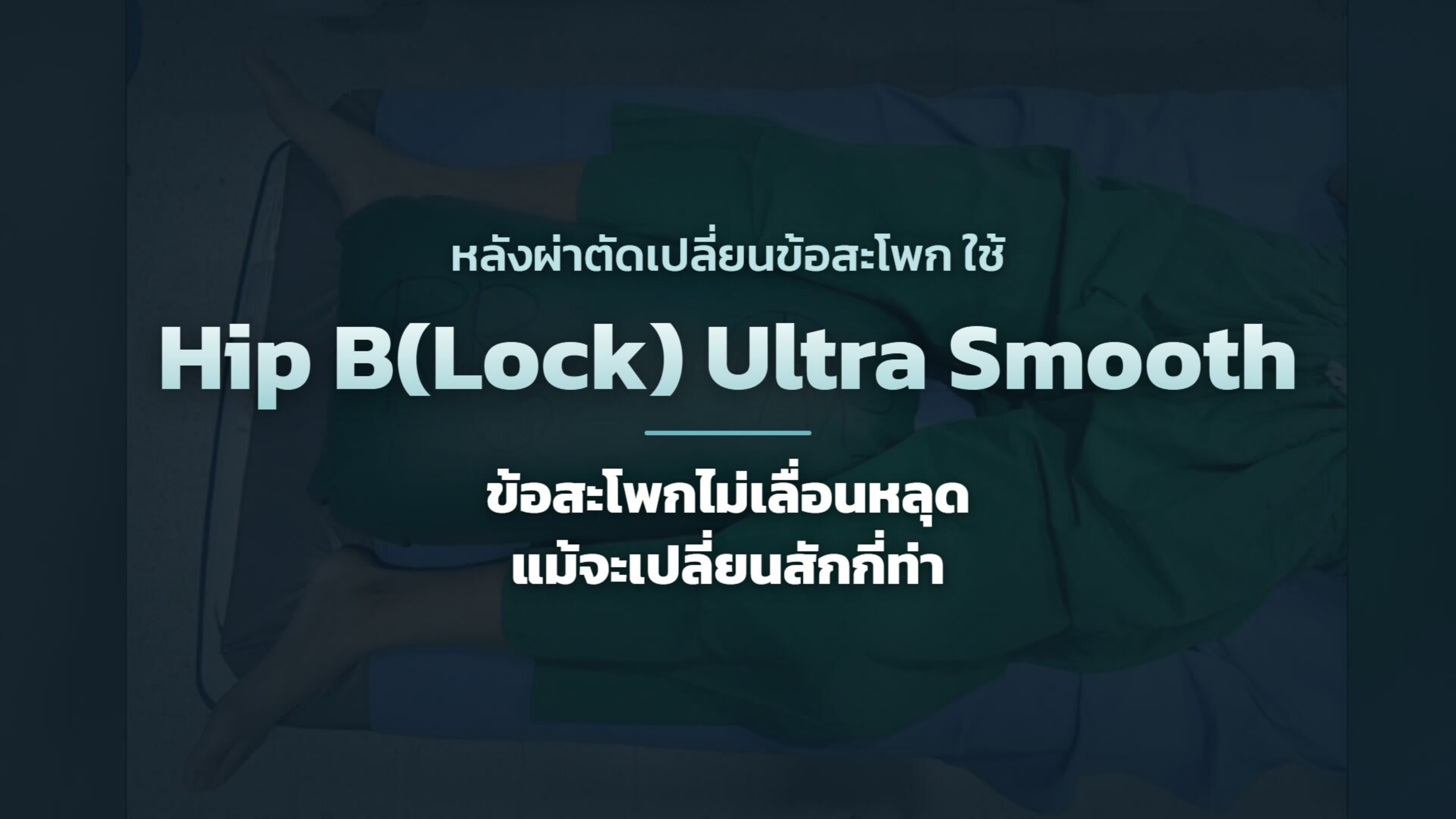
3. ตรวจทางรังสี (X-ray)

ถ่ายภาพรังสีหลังผ่าตัดได้ทุกราย 100%
ไม่ต้องใช้อุปกรณ์จัดท่าเพิ่ม

4. ความพึงพอใจของบุคลากร

ร้อยละ 87.1 สูงกว่าเป้าหมาย เด่นเรื่องจัดท่าสะดวก สลับใช้ได้ทั้งซ้ายและขวา และคุ้มค่าการใช้งาน

ผลลัพธ์ ผ่านเกณฑ์ ครบ 4 ด้าน | ต้นทุนเพียง **613 บาท**


หลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพก ใช้
Hip B(Lock) Ultra Smooth
ข้อสะโพกไม่เลื่อนหลุด
แม้จะเปลี่ยนสักกี่ท่า

Thank you

Hip B(Lock) Ultra Smooth
หน่วยผ่าตัดออร์โธปิดิคส์ โรงพยาบาลศิริราช